

SAIRA-CHRISTINE RENTERIA

NOTE D'INFORMATION

Supervision en psychosomatique

Informations à l'intention des médecins-assistant·es en formation

Lausanne · Juillet 2026

1 Pourquoi une supervision en psychosomatique ?

Vous avez choisi une spécialité magnifique et exigeante, profondément humaine, à la croisée du soin, de l'intime et des contextes de vie. Vous êtes appelé·es à accompagner des femmes à des moments clés de leur existence : premières règles, grossesse, naissance, pré-IG, infertilité, ménopause, cancer, deuil périnatal, sexualité, violence...

Or, dans votre quotidien, ces moments ne se vivent pas toujours dans la douceur et la clarté. Ils sont souvent marqués par la souffrance, la confusion, la peur, la colère, le silence - chez vos patientes, et parfois aussi en vous.

La gynécologie et l'obstétrique sont des disciplines profondément enracinées dans les expériences de vie, les récits intimes et les transformations corporelles de la personne en lien avec sa santé reproductive. Accompagner les femmes et des couples dans ces passages - souvent marqués par la vulnérabilité, les espoirs, les pertes ou les conflits intérieurs - exige bien plus que des compétences techniques.

Or, la médecine psychosomatique offre précisément les outils pour développer cette compréhension globale de la patiente, en articulant les dimensions biologiques, psychologiques et sociales. Elle donne sens aux plaintes fonctionnelles, éclaire les trajectoires de santé, et invite à une posture médicale plus réflexive, ajustée et humaine.

Dans votre formation en gynécologie-obstétrique, vous êtes rapidement confronté·e à des situations cliniques où le savoir médical pur ne suffit plus. Vous rencontrez des patientes dont la plainte ne trouve pas d'explication biologique claire, ou dont les réactions vous paraissent disproportionnées, déroutantes, voire dérangeantes. Vous êtes parfois dans l'incertitude, entre écoute et distance, responsabilité et surcharge, soin et limite.

Certaines de ces situations s'imposent par leur intensité : accouchement traumatique, fausse couche tardive, IMG, annonce de cancer, désir d'enfant contrarié, violence conjugale ou sexuelle révélée dans le secret du cabinet.

D'autres sont plus subtiles : des pleurs inexplicables, une demande qui vous déstabilise, un geste que vous redoutez de faire, un malaise diffus lors d'une consultation, ou une réaction en vous que vous ne comprenez pas.

La supervision psychosomatique propose un espace pour penser ces moments autrement. Elle vous permet de prendre du recul, de mieux comprendre ce qui est en jeu dans la relation médecin-patient, et de développer une posture professionnelle ajustée, respectueuse de votre rôle, de vos limites, et de la personne que vous avez en face de vous.

2 Ce que vous vivez

Beaucoup de situations sont propices à toucher les professionnel·les que nous sommes, sans que nous sachions toujours comment ou pourquoi. Certain·es penseront que la solution est de s'endurcir ; d'autres se verront dire qu'ils ou elles sont trop sensibles. L'acquisition de compétences en psychosomatique permet justement d'éviter ces réactions polarisées, en développant une posture professionnelle souple, capable de rester ouverte sans se laisser envahir, et de se protéger sans se rigidifier. Cela peut être :

- l'attente d'un couple pour qui chaque jour de grossesse semble compter double ;
- l'abattement d'une femme en pleine chimiothérapie, à laquelle vous devez malgré tout annoncer une complication ;

- l'agressivité d'une patiente suivie en PMA, qui vous laisse désespéré·e ;
- la fatigue accumulée après un accouchement difficile, dont la trace émotionnelle reste longtemps après la garde ;
- le flottement lors d'un entretien pré-IG, où vous sentez que les mots ne suffisent pas ;
- le trouble face à une patiente victime de violences sexuelles, dont l'examen vous confronte à vos propres limites ;
- ou ce malaise diffus, presque impossible à nommer, dans certaines consultations qui accrochent.

Mais aussi : des patientes qui vous idéalisent, ou vous rejettent sans que vous sachiez pourquoi ; des interactions au sein de l'équipe qui vous laissent mal à l'aise ; une surcharge émotionnelle dont vous n'arrivez pas à vous défaire ; ou encore cette sensation de porter, seul·e, quelque chose de trop lourd ; ou ce moment de doute face à vos propres limites, où la culpabilité ou la peur de mal faire vous habite.

3 Pourquoi en parler ? Pourquoi réfléchir ensemble ?

Ces situations ne peuvent pas toujours être résolues. Mais elles peuvent être pensées. La supervision psychosomatique est précisément là pour cela.

C'est un espace pour :

- déplier ce que vous avez vécu en consultation, dans la salle de garde ou en discussion d'équipe ;
- identifier les éléments en jeu - biologiques, psychiques, relationnels, sociaux - chez la patiente, mais aussi chez vous ;
- comprendre vos réactions émotionnelles ou corporelles, qui sont des signaux précieux dans la relation de soin ;
- nommer des malaises ou des tensions, les mettre en mots, les partager, les élaborer ;
- élargir vos ressources pour accompagner les situations difficiles, sans vous épuiser ni vous enfermer dans des rôles impossibles.

4 Comment cela fonctionne-t-il ?

La supervision n'est ni une évaluation, ni un débriefing, ni une thérapie. Elle ne cherche pas à corriger vos gestes médicaux, mais à accompagner votre cheminement dans des situations humaines complexes. C'est un espace de parole libre et protégée, où chacun·e peut déposer, sans être jugé·e, ce qu'il ou elle vit au quotidien.

CONFIDENTIALITÉ Ce qui est dit au sein du groupe reste dans le groupe. La règle est absolue. Elle permet à chacun·e de s'exprimer avec confiance et sécurité.

La communication dans le groupe se fait sous le signe de l'écoute active et du respect mutuel. Il n'y a pas de bonne manière de raconter, pas de hiérarchie dans les vécus. Tout ce qui est partagé a une valeur, dès lors que cela vous touche ou vous interroge.

- Les séances ont lieu en groupe restreint, dans un cadre confidentiel et non jugeant.
- Vous êtes invité·e à apporter une situation vécue, pas forcément exceptionnelle ni spectaculaire, que vous souhaitez explorer.

- À l'aide d'outils issus de l'approche bio-psycho-sociale, nous analysons ensemble ce qui se joue dans la relation, dans le discours de la patiente, dans vos propres réactions.
- Aucune préparation formelle n'est attendue pour les premières séances. Votre vécu suffit.

LE RÈGLEMENT Il exige une participation à un minimum de 4 séances, ainsi que la remise d'un travail personnel en fin de parcours. Ce travail consiste en la description d'un cas clinique dans lequel vous avez appliqué les réflexions et attitudes développées au cours des séances. Idéalement, il reflète votre propre évolution et l'acquisition de compétences complémentaires dans ce domaine.

5 Ce qui se travaille en supervision

Elle permet de mieux repérer les effets corporels du stress : tensions physiques persistantes, somatisations, réactions de défense ou d'alerte que votre propre corps exprime parfois avant votre mental. Prendre en compte ce langage corporel permet d'agir en prévention, en ajustement, et en conscience.

Il ne s'agit pas ici d'ajouter un cours de plus à votre programme chargé. Il s'agit d'un espace de formation clinique, où vous allez acquérir des compétences essentielles mais peu enseignées formellement :

- lire une situation dans sa globalité, au-delà des symptômes ;
- repérer les dynamiques relationnelles, les transferts, les attentes, les tensions implicites ;
- travailler la posture médicale dans l'incertitude ou l'ambivalence ;
- identifier ce qui appartient à la patiente et ce qui vous appartient à vous, et naviguer entre les deux ;
- trouver une juste distance émotionnelle, qui protège sans couper ;
- poser des limites claires, sans rigidité ni culpabilité ;
- rester présent·e, même quand la technique ne suffit plus.

Ces compétences ne s'ajoutent pas à la médecine. Elles en sont le cœur vivant, dès que l'on soigne des êtres humains dans leur histoire, leur complexité, leurs contradictions.

6 Décoder vos réactions corporelles de soignant·e

Lorsque nous évoquons ces effets corporels du stress, il ne s'agit pas d'une démarche thérapeutique personnelle, mais d'un apprentissage professionnel spécifique. En tant que soignant·e, votre corps constitue un récepteur d'informations qui perçoit et traite une multitude de signaux lors des consultations.

Ces réactions corporelles - tension dans les épaules lors d'un entretien difficile, sensation d'oppression face à certaines révélations, fatigue particulière après certaines gardes - constituent des données cliniques précieuses. Elles vous renseignent sur ce qui se joue dans la relation de soin : l'anxiété non-dite d'une patiente, une dynamique relationnelle complexe, ou encore vos propres limites professionnelles.

Apprendre à reconnaître et décoder ces signaux vous permet de :

- utiliser ces informations comme boussole dans la relation de soin ;
- prendre des décisions professionnelles plus éclairées : orientation, collaboration, pause.

Cette approche s'inscrit pleinement dans votre développement professionnel et complète utilement d'autres ressources que vous pourriez mobiliser par ailleurs : accompagnement thérapeutique personnel, pratiques de mindfulness, groupes de pairs voire cercles de qualité (CQ), ou autres approches de gestion du stress selon vos besoins individuels.

7 Vers une posture professionnelle ancrée, lucide et humaine

Que ce soit en obstétrique, en gynécologie, en oncologie ou dans l'accompagnement des effets de la violence ou de la précarité, la supervision psychosomatique vous aide à habiter votre rôle de soignant·e avec justesse et humanité.

Elle permet aussi de travailler des questions identitaires profondes : quel·le médecin suis-je en train de devenir ? Comment rester fidèle à mes valeurs dans des environnements exigeants, parfois contraignants ? Comment faire équipe sans me perdre dans des jeux de rôle ?

La supervision psychosomatique est une démarche qui vous permet de vous professionnaliser en restant vivant·e, de développer votre discernement clinique sans vous couper de votre sensibilité, et de faire face à la réalité complexe du soin sans vous y perdre.

Elle vous accompagne dans votre propre développement en tant que médecin, au fil des situations que vous traversez, et vous aide à devenir et rester un·e soignant·e compétent·e, attentif·ve, structuré·e et humain·e.

Pour aller plus loin

Ce travail de réflexion s'inscrit dans le cadre des exigences officielles de la formation postgraduée FMH en gynécologie-obstétrique. Programme complet, ISFM / SIWF, révision 2022 :

<https://www.siwf.ch/files/pdf10/fm-ch-f-m-gynaekologie-und-geburtshilfe-20220701-f.pdf>

JE ME RÉJOUIS DE VOUS ACCUEILLIR DANS CE GROUPE

Pour toute question d'organisation, n'hésitez pas à me contacter directement.

SAIRA-CHRISTINE RENTERIA

Lausanne